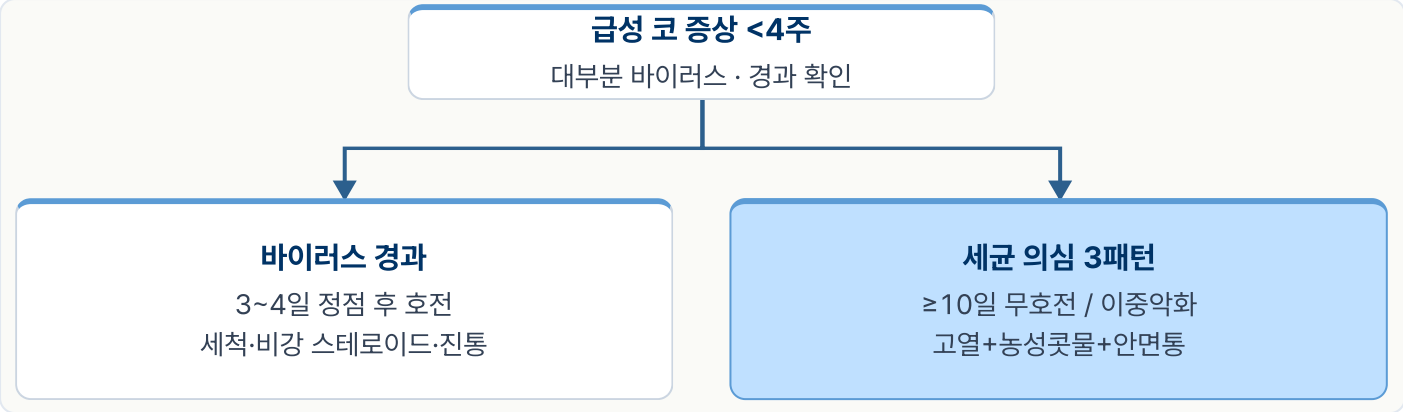
의료진 진료 카드 · ASL-080

# 급성 비부비동염 · 관찰과 항생제

누런 콧물 자체는 세균의 증거가 아니다. 시간·이중악화·중증 소견으로 구분한다.

## 세균 의심 패턴과 관찰의 조건




## 본강의 · ABRS 의심

| | |
|---|---|
| 지속·이중악화 | ≥10일 호전 없이 지속, 또는 좋아지다 5~6일째 다시 악화. 감기 환자 중 세균 동반 약 0.5~2%로 소개. |
| 중증 | 고열 ≥39°C + 농성 콧물 + 안면통 3~4일의 교재 기준. 강의 상황표는 고열 39°C·심한 안면통 3일이면 즉시 amox/clav·추적으로 제시. |
| 색깔 | 노랑·초록은 호중구·myeloperoxidase 색이며 감기 3~4일째 정상 경과에서도 나타남. 색보다 기간과 악화 양상으로 판단. |

## 본강의 · 초기 치료와 안전망

| | |
|---|---|
| 경과관찰 | 합병증 없는 ABRS는 경과관찰 제시 가능. 진통·해열제, 식염수 세척, 비강 스테로이드로 증상 치료. |
| 안전망 처방 | WASP/SNAP: 처방전을 주되 바로 복용하지 않고 3~5일 더 관찰, 호전 없거나 악화하면 시작. 중증 즉시치료 사례와 구분. |
| 급성기 보조 | Mometasone은 급성 비부비동염 적응증으로 아침·저녁 사용을 소개. 비강 충혈완화제 >5일 금지. 알레르기 없는 경우 경구 항히스타민 효과는 제한적. |

즉시 의뢰 소견: 편측·혈성 분비물, 안와 부종·복시·시력저하, 심한 두통·의식변화·고열·경부강직 등 신경 증상, 면역저하. 합병증 없는 급성 비부비동염의 관찰 경로와 분리한다.

의료진 진료 카드 · ASL-080

# 급성 세균성 · 성분 함량과 재평가

강의에 제시된 성인 용법. amoxicillin/clavulanate 성분 함량으로 비교하고 설사·실패를 구분한다.

## 본강의 · 1차 항생제

| | |
|---|---|
| **표준 용법** | Amoxicillin/clavulanate 500/125mg 1일 3회 또는 875/125mg 1일 2회, 5~7일. 제품 총량·정수보다 두 성분 함량으로 구분. |
| **고위험** | ≥65세, 최근 4주 내 항생제·입원, 면역저하, 중증: 고용량 amox/clav, amoxicillin 기준 2g 1일 2회, 7~10일로 소개. |
| **국내 선택 이유** | 교재: H. influenzae ampicillin 내성 약 58%·β-lactamase 약 52%, M. catarrhalis 거의 100% β-lactamase. 국내에서는 amox 단독보다 병합 선호라는 강의 설명. |
| **재평가** | 관찰 중 3~5일(최대 약 7일) 무호전이면 항생제 시작 고려. 복용 중 3~5일 무호전이면 바꾸기 전 진단·합병증·순응도 재평가. |

## 연자 Q&A · 설사와 치료 실패

| | |
|---|---|
| **설사·제형** | 625mg(500/125) 하루 3회 → 1g(875/125) 하루 2회 변경을 우선한다는 답변. 하루 clavulanate 375→250mg으로 줄고 amoxicillin은 증가. |
| **복용·대안** | Q&A는 식사 시작 때 복용, S. boulardii·LGG 보조를 제시. Amoxicillin 단독 500mg 하루 3회 또는 875mg 하루 2회도 소개했으나 β-lactamase 균을 놓칠 수 있다고 설명. |
| **설사 위험** | 열·혈변·복통이 동반되거나 항생제 중단 후 지속하면 C. difficile 평가. 단순 제형 관련 설사와 구분. |
| **무호전** | 적절한 항생제 3~5일 후에도 무호전이면 세균성인지, 바이러스·알레르기·치성 원인, 눈·머리 합병증, 복용 여부를 먼저 본다. 실패 시 2세대 세파로 하향 변경하지 않고 배양·의뢰 고려. |

설사로 약을 바꾸는 상황과 적절한 치료 후에도 감염이 호전되지 않는 상황을 구분한다. 성분 함량·복용법을 확인하고, 지속 설사의 동반 증상과 치료 실패 원인을 다시 평가한다.

의료진 진료 카드 · ASL-080

# 대체약 · 알레르기와 실패 경로

항생제 변경 전 재평가가 먼저다. 아래 국내 내성·대안은 본강의 및 연자 Q&A의 설명.

## 본강의 · 대체 항생제의 자리

| | |
|---|---|
| **경구 세파** | Amox/clav·levofloxacin 불가 또는 실패 시 cefditoren(메이액트) 1순위, cefpodoxime·cefdinir 차선. Cefuroxime 단독 1차 비권장, cefaclor는 부적절로 소개. 고도 내성 실패 시 경구 세파에도 한계가 있어 ceftriaxone 또는 배양·의뢰. |
| **피하는 경험적 선택** | 폐렴구균 macrolide 내성 70~80%, TMP/SMX 내성 30~40%+, tetracycline 내성 73~83%로 소개. Macrolide·TMP/SMX·cefaclor·doxycycline을 일률적 경험적 대체로 권하지 않음. |
| **호흡기 FQ** | Levofloxacin 내성 3~7%, moxifloxacin <2%로 소개했으나 중증 penicillin 알레르기·치료 실패·내성균 의심 때 제한. 건염·건파열·QT 연장·혈당 이상·말초신경병증·대동맥류/박리 위험. |

## 연자 Q&A · 알레르기와 설사 대안

| | |
|---|---|
| **병력 선별** | 5년 이내 반응, 아나필락시스·혈관부종, 박리·점막 침범, 응급실·치료 여부 질문. 위험 낮은 병력은 알레르기내과 경구유발검사로 평가 가능하다고 답변. |
| **곁사슬·중증** | 비중증 병력이고 R1이 다른 세파는 대체 가능성이 있으나, 아나필락시스는 첫 복용 병원 관찰 약 30분 또는 전문의 상의; SJS·DRESS 병력은 베타락탐 회피 후 의뢰라는 답변. |
| **두 계열 진성 알레르기** | Levofloxacin 500mg 하루 1회 5~7일 또는 moxifloxacin 400mg 하루 1회 5~7일을 대안으로 설명. 위의 FQ 위험 때문에 꼭 필요한 경우만 사용한다는 답변. |
| **설사 시 cefuroxime** | Q&A는 설사 대안으로 cefuroxime axetil 500mg 하루 2회도 소개. 이는 amox/clav 치료 실패 후 2세대로 바꾸지 말라는 설명과 다른 상황. |

## 재평가 뒤 연결

### 치료 실패

약을 계속 추가하기 전에 진단·복용·치아·안와/신경 합병증을 다시 본다. 세균성 실패면 범위를 조정하거나 내시경·배양 가능한 이비인후과 의뢰.

### 12주 이상 지속

만성 비부비동염은 내시경/CT 객관 소견을 확인하는 별도 경로. INCS+세척이 중심이며 반복 급성 항생제 처방만으로 해결하지 않는다는 강의 설명.